

Síncope

J. de Burgos Marín, F. J. Montero Pérez, Y. Herrero González, M. J. Clemente Millán, C. Tirado Valencia y L. Jiménez Murillo

CONCEPTO Y ETIOLOGÍA

El *síncope* se define como la pérdida brusca de la conciencia y del tono muscular, de corta duración (segundos o pocos minutos) y con recuperación espontánea *ad integrum*, secundaria a la disminución o interrupción del flujo sanguíneo cerebral. Se estima que entre el 9 y el 35% de la población española presenta algún episodio sincopal en su vida. El síncope constituye el 3% de las consultas a un servicio de urgencias y es el causante del 6% de los ingresos.

Desde el punto de vista fisiopatológico, el síncope puede originarse por hipotensión arterial brusca (presión arterial sistólica [PAS] < 70 mmHg o presión arterial media [PAM] < 30 mmHg), hipoxemia, disminución selectiva de la perfusión cerebral, hipovolemia y disminución del gasto cardíaco por alteración cardíaca primaria. Las causas que con más frecuencia pueden provocar el cuadro sincopal se muestran en el [cuadro 61.1](#).

Según su mecanismo de producción, hay tres patrones clínicos de síncope:

1. **Tipo vasodepresor.** Se caracteriza inicialmente por hipotensión.
2. **Tipo cardioinhibitorio.** Predomina la bradicardia.
3. **Tipo mixto.** Presenta una respuesta combinada de hipotensión y bradicardia.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico del síncope es eminentemente clínico, y las diferentes exploraciones complementarias se utilizan para dilucidar su etiología.

CLÍNICA

El **síncope** se produce generalmente de manera brusca; sin embargo, a veces se precede de síntomas prodrómicos que pueden incluir malestar general, sensación nauseosa y de inestabilidad, visión borrosa, debilidad, sudoración y acúfenos. En ocasiones, este pródromo no se continúa con una pérdida de conciencia si el paciente se coloca en decúbito supino, en posición de Trendelenburg o con las piernas elevadas. Esta situación se denomina **presíncope** y habitualmente es de origen circulatorio (vasovagal, ortostático o reflejo).

Independientemente de que haya habido o no síntomas prodrómicos, durante el cuadro sincopal el paciente se encuentra pálido, sudoroso, hipotenso, hipopneico e

inmóvil. En ocasiones, el episodio se inicia con una contractura tónica de muy breve duración, y es infrecuente que se acompañe de relajación de esfínteres y de movimientos clónicos de los miembros superiores (**síncope convulsivo**). Este fenómeno ocurre fundamentalmente cuando al paciente que está experimentando un síncope no se le coloca en la posición adecuada (ya descrita) y se perpetúa la disminución del flujo sanguíneo cerebral. Dado que normalmente el paciente es atendido una vez que ha pasado el episodio agudo, la descripción del cuadro por un testigo presencial es básica para establecer el diagnóstico.

Una vez realizado el diagnóstico de síncope, su forma de presentación, los síntomas premonitores y coincidentes, la duración del cuadro clínico, el tiempo de comienzo y recuperación, así como la persistencia de los síntomas después de la recuperación del estado de conciencia, son factores que contribuyen a descubrir su causa más probable ([tabla 61.1](#)) y a identificar los **síncopes de alto riesgo**. Se consideran así los que se desencadenan en decúbito o después del esfuerzo, los que tienen una duración prolongada o se repiten en un breve espacio de tiempo, los acompañados o precedidos de dolor torácico, disnea o cefalea, y los que presentan focalidad neurológica posterior. Para estratificar el riesgo fiable de estos pacientes se puede utilizar la **regla de San Francisco**, que incluye los siguientes criterios: 1) antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva; 2) de disnea; 3) anormalidad electrocardiográfica, hematocrito inferior al 30%, y 4) PAS inferior a 90 mmHg. La presencia de cualquiera de estos criterios obliga a considerar al paciente de alto riesgo de tener una complicación grave (infarto agudo de miocardio, arritmias, tromboembolia pulmonar [TEP], accidente cerebrovascular, hemorragia subaracnoidea o hemorragia interna).

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LOS SÍNCOPES MÁS FRECUENTES

- **Síncope vasovagal o lipotimia.** Es el más frecuente, especialmente en jóvenes sanos. Se produce un descenso de la presión arterial por vasodilatación refleja y bradicardia. Generalmente hay factores desencadenantes, como ambiente caluroso, bipedestación prolongada, estrés emocional, dolor o ansiedad. La pérdida de conciencia se produce cuando el sujeto está en posición erecta y suele ir precedida de síntomas vegetativos, como sofocación, náuseas, vómitos, palpitaciones, visión borrosa, acúfenos y malestar abdominal. Se puede utilizar la **escala de Cal-**

CUADRO 61.1 Causas más frecuentes de síncope**ORIGEN CARDÍACO****Obstrutivo (3-11%)**

Cavidades izquierdas.
 Estenosis aórtica y mitral.
 Miocardiopatía hipertrófica.
 Mixoma auricular.
 Disección aórtica.
 Disfunción protésica.
 Cavidades derechas.
 Tromboembolia pulmonar.
 Taponamiento cardíaco.
 Hipertensión pulmonar primaria.
 Estenosis pulmonar.
 Cardiopatías congénitas.

Eléctrico

Bradiarritmias o taquiarritmias (5-30%).

Isquémico

Infarto agudo de miocardio.

ORIGEN NO CARDÍACO**Circulatorio (40%)**

Vasovagal o lipotimia.
 Ortostático.
 Hipotensión posprandial.
 Reflejo (tusígeno, miccional, defecatorio).
 Hipersensibilidad del seno carotídeo.
 Hipovolemia (hemorragia digestiva alta, enfermedad de Addison).

Neurológico (4-5%)

Vascular.
 Isquémico.
 Hemorragia subaracnoidea.
 Síndrome de robo de subclavia.
 Migraña basilar.
 Crisis comicial.

Psicógeno

Hiperventilación.
 Trastorno de conversión.

Otros

Hipoxemia.
 Hipoglucemia.
 Intoxicación etílica.
 Intoxicación o efectos secundarios de fármacos (diuréticos, hipotensores, bloqueadores β).

ORIGEN DESCONOCIDO

Entre el 38 y el 47%.

gary para diferenciar el síncope vasovagal de cualquier otra causa de síncope (tabla 61.2).

- **Síncope ortostático o postural.** Es frecuente en los ancianos. Habitualmente se produce cuando el paciente adopta la bipedestación después de estar en decúbito o pocos minutos después. Suele precederse de prodromos, como en el caso anterior, aunque a veces se desencadena de forma brusca.
- **Síncope por hipotensión posprandial.** En la actualidad se considera una afección distinta y probablemente más frecuente que la hipotensión ortostática, sobre todo en ancianos. Se define por una disminución de la PAS

superior a 20 mmHg dentro de las 2 h siguientes al comienzo de la ingestión (*dumping* precoz).

- **Síncope por dolor.** Está muy relacionado con la lipotimia, ya que también se produce por estímulo vagal. Cualquier dolor intenso puede producirlo, pero es característico el que se desencadena al deglutir en pacientes con neuralgia del glosofaríngeo.
- **Síncope tusígeno.** Generalmente aparece en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica después de un acceso de tos. También puede ser provocado por paroxismos de estornudo o risa. Hay que descartar una hemorragia intracraneal.
- **Síncope miccional.** Es prácticamente exclusivo de los hombres. Es frecuente después del consumo de abundantes líquidos de contenido etílico, como la cerveza, y ocurre típicamente durante la micción o inmediatamente después de ella. El mecanismo patogénico es mixto: hipotensión ortostática y estimulación vagal originada por el rápido vaciamiento de la vejiga.
- **Síncope por hipersensibilidad del seno carotídeo.** Un tercio de los ancianos tiene hipersensibilidad del seno carotídeo, aunque curse de manera asintomática. El síncope puede producirse al comprimir el seno carotídeo durante el afeitado, apretarse el nudo de la corbata, abrocharse la camisa o al mover bruscamente la cabeza. Asimismo, hay una serie de fármacos que aumentan la hipersensibilidad del seno, como la digoxina, la cafeína, el calcio, los nitratos, los colinérgicos y los bloqueadores β .
- **Síncope cerebrovascular.** Se origina por una disminución del flujo sanguíneo cerebral, ocasionada por un estrechamiento de los vasos, trombosis o embolia. Entre sus causas más frecuentes se encuentra la insuficiencia arterial vertebrobasilar, el síndrome del robo de la subclavia y la enfermedad de Takayasu. La obstrucción de solo una arteria carótida no origina síncope.
- **Síncope cardiogénico.** El síncope de origen cardíaco se asocia con mayor tasa de morbilidad y mortalidad que el resto de los cuadros sincopales. Las alteraciones electrocardiográficas que sugieren este tipo de síncope se exponen más adelante.

PRUEBAS DE PROVOCACIÓN

Son una serie de pruebas que permiten que el cuadro sincopal se reproduzca en presencia del médico. Solo está indicada su realización cuando exista duda acerca del mecanismo de producción del síncope, siempre con monitorización previa del paciente y una vez descartados procesos más graves. Las más utilizadas son las siguientes:

- **Mesa basculante (*tilt test*).** Se utiliza para el diagnóstico del síncope vasovagal. Consiste en reproducir en el paciente una reacción vagal mediante distintas inclinaciones.
- **Ortostatismo.** Se toma la presión arterial en decúbito y después de permanecer el paciente 3 min en bipedestación. El diagnóstico de hipotensión ortostática, independientemente de que se acompañe o no de síntomas, se realiza cuando el paciente tiene una PAS inferior a 90 mmHg, un descenso de la PAS superior a 20 mmHg

TABLA 61.1 Diagnóstico etiológico clínico del síncope

Elementos claves para el diagnóstico	Características clínicas	Tipo o causa de síncope
Forma de presentación y circunstancias desencadenantes	Postura	
	Decúbito	Cardiogénico Hipoglucemia Psicógeno
	Al incorporarse	Ortostático
	Tras estar de pie	Ortostático
	Posición especial	Mixoma auricular
	Ejercicio	
	Durante el esfuerzo	Cardiopatía obstructiva Arritmia Robo de subclavia
	Después del esfuerzo	Miocardopatía hipertrófica
	Otras	
	Nocturno en el inodoro	Miccional, defecatorio
	Ataque de tos	Tusígeno
	Dolor agudo	Reflejo
	Deglución dolorosa	Neuralgia del glosofaríngeo
	Anudarse la corbata	Hipersensibilidad del seno carotídeo
	Movimientos de cabeza	Hipersensibilidad del seno carotídeo
	Ansiedad	Vasovagal, psicógeno
Pródromos	Clínica vegetativa	Vasovagal
	Parestesias, ansiedad	Hiperventilación
	Brusco, sin aviso	Cardíaco, neurológico
	Aura	Migraña basilar
Síntomas coincidentes	Palpitaciones	Arritmias
	Dolor torácico	Enfermedad coronaria Tromboembolia pulmonar Disección aórtica
	Déficit neurológico	Ataque isquémico transitorio
Tiempo de comienzo	Comienzo lento y recuperación rápida	Vasovagal
	Comienzo y recuperación rápidos	Arritmia
	Comienzo rápido y recuperación lenta	Crisis comicial
	Comienzo y recuperación lentos	Causa metabólica
Duración	Prolongada	Estenosis aórtica Hipoglucemia Psicógeno
Persistencia de síntomas	Cefalea intensa	Hemorragia subaracnoidea Migraña basilar
	Confusión	Crisis comicial

TABLA 61.2 Escala de Calgary

Pregunta	Puntuación*
¿Tiene antecedentes de al menos alguna de las siguientes patologías: bloqueo fascicular o bifascicular, asistolia, taquicardia supraventricular o diabetes mellitus?	-5
Si hubo testigos durante el síncope, ¿vieron si se puso azul (cianótico)?	-4
¿Los episodios de síncope comenzaron a los 35 años o después de esta edad?	-3
¿Recuerda algo mientras estaba inconsciente?	-2
¿Tiene mareos o desmayos cuando está sentado o de pie por mucho tiempo?	+1
¿Tiene sudoración o siente calor antes del desayuno?	+2
¿Tiene mareos o desmayos con el dolor o con las maniobras médicas?	+3

*La puntuación solo se suma o resta si la respuesta a la pregunta es afirmativa. Un resultado total mayor o igual a -2 indica síncope de etiología vasovagal.

o una disminución de la presión arterial diastólica mayor de 10 mmHg.

- **Maniobra de Valsalva.** Se producen hipotensión y taquicardia compensadora durante la fase de presión, y puede reproducir el síncope si este ha sido provocado por la micción o la defecación.
- **Taquipnea forzada.** Después de hiperventilar al paciente durante 2 min, puede desencadenarse un síncope por hiperventilación.
- **Masaje del seno carotídeo.** Después de medir la presión arterial y monitorizar al paciente, se le da un masaje, primero en la carótida derecha y después en la izquierda. Puede producirse una asistolia superior a 3 s (efecto cardioinhibitorio) o una disminución de la PAS superior a 30 mmHg (efecto vasodepresor). Esta prueba está contraindicada en pacientes con antecedentes de enfermedad cerebrovascular o con patología del nódulo sinusal.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

En todos los pacientes diagnosticados de síncope, aunque se sospeche origen vasovagal, ortostático o reflejo, deben solicitarse las siguientes exploraciones complementarias urgentes:

- **Electrocardiograma.** Es patológico en el síncope de origen cardíaco. Pueden encontrarse las siguientes alteraciones:
 - Bloqueo bifascicular (definido como bloqueo completo de la rama izquierda o bloqueo de la rama derecha asociado a hemibloqueo anterior o posterior de la rama izquierda).
 - Bloqueo auriculoventricular de segundo grado de tipo Mobitz I.
 - Bradicardia sinusal asintomática (< 50 lat/min) o bloqueo sinoauricular.
 - Complejos QRS de preexcitación.
 - Intervalo QT prolongado.
 - Bloqueo de la rama derecha con elevación del segmento ST en las derivaciones V₁ a V₃ (síndrome de Brugada).

- Ondas T negativas en precordiales derechas, ondas epsilon y potenciales ventriculares tardíos, sugestivos de displasia arritmogénica del ventrículo derecho.
- Ondas Q sugestivas de infarto de miocardio.

- **Glucemia mediante tira reactiva.** Permite descartar una hipoglucemia.

El resto de las exploraciones complementarias que se mencionan a continuación solo deben realizarse ante una sospecha clínica etiológica fundada:

- **Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios,** si se sospecha anemia o proceso séptico.
- **Bioquímica sanguínea,** que incluya determinación de glucosa, urea, creatinina e iones, cuando se sospechen alteraciones hidroelectrolíticas. Si se prevé patología coronaria, debe solicitarse la determinación de la troponina.
- **Radiografía posteroanterior y lateral de tórax,** en caso de insuficiencia cardíaca o alteraciones electrocardiográficas, o sospecha de hernia hiatal que pueda comprimir la aurícula izquierda.
- **Gasometría arterial,** si hay hiperventilación, si la saturación periférica de oxígeno (medida por pulsioximetría) es inferior al 92% o si se sospecha TEP.
- **Ecocardiograma,** ante la sospecha de un síncope cardíaco obstructivo: taponamiento cardíaco, valvulopatía, miocardiopatía hipertrófica obstructiva o disección aórtica.
- **Tomografía computarizada (TC) craneal,** si se sospecha isquemia cerebral o hemorragia subaracnoidea. En este último caso se practica punción lumbar si la TC es normal.
- **Angiografía por TC,** si se sospecha TEP.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL (TABLA 61.3)

Se establece principalmente con:

- **Crisis epiléptica.** En el síncope puede haber relajación de esfínteres y convulsiones, aunque no sean de origen epiléptico. Sin embargo, la crisis epiléptica es más

TABLA 61.3 Características clínicas de las crisis tónico-clónicas, los eventos no epilépticos de origen psicógeno y los síncope

	Crisis tónico-clónicas*	Eventos no epilépticos de origen psicógeno	Síncope
Desencadenante	Escaso	Frecuente, situacional	Frecuente, en caso de síncope reflejos (tos, ortostatismo prolongado) y síncope ortostáticos (al levantarse)
Durante el sueño	Dependiendo del tipo de epilepsia, frecuente (epilepsia frontal)	No [†]	Escasos (solo síncope cardíacos)
Caídas	Frecuentes (tónico, «rígida como un tronco»)	Escasas	Frecuentes (atónico, «flojo como un saco»)
Color de la piel	A veces, cianótico	Rosado	Frecuentemente pálido
Ojos	Abiertos, mirada pérdida, desviación ocular	Cerrados, resistencia al intentar abrir los ojos de forma pasiva	Abiertos, girados hacia arriba
Duración	0,5-3 min	A menudo > 5 min	1-30 s
Sonidos	Frecuentes («grito epiléptico»)	Frecuentes (lloro, resoplido, gemido, tos)	Escasos (gruñidos, ronquidos)
Movimientos	Bilaterales tónico-clónicos, usualmente antes de la caída	Asíncronos, movimientos de la cabeza de lado a lado, opistótonos	Bilaterales, breves, asíncronos, usualmente después de la caída
Enuresis	Frecuente	Escasa	Escasa
Mordedura lingual	Frecuente, lateral	Escasa	Escasa, punta
Recuperación	Lenta (varios minutos, primer recuerdo después del episodio en la ambulancia o el hospital)	Rápida, fatiga postictal	Rápida (varios segundos, primer recuerdo después del episodio en la escena)

*Crisis generalizada tónico-clónica o crisis secundariamente generalizada.

[†]En ocasiones, parece como si el paciente estuviera durmiendo.

prolongada, de recuperación más lenta, está precedida de aura y el paciente suele presentar estado poscrítico.

- **Vértigo.** Puede confundirse con el presíncope, ya que en el vértigo no hay pérdida de conciencia. El paciente refiere una sensación giratoria de los objetos, o de él mismo, que se acompaña de nistagmo.
- **Drop attack.** Es una pérdida brusca del equilibrio y del tono muscular, sin pérdida de conciencia, originada por una insuficiencia vertebrobasilar. Se asocia a otros síntomas, como vértigo, disartria, etc.
- **Hipoglucemia.** La determinación de la glucemia mediante tira reactiva descarta o confirma este diagnóstico.
- **Caída accidental.** Es muy frecuente en los ancianos.
- **Accidente isquémico transitorio.** Se acompaña de focalidad neurológica.
- **Simulación.** El paciente se opone a la exploración física de tal manera que, aunque aparentemente está inconsciente, no permite la apertura de los ojos, contrayendo los párpados de forma voluntaria.
- **Seudósíndrome psicógeno.** Es un trastorno de conversión en el que hay una pérdida aparente de la conciencia (5-20 min) sin alteración de la perfusión ni de la función cerebrales. Todas las exploraciones complementarias son normales.

CRITERIOS DE INGRESO

Requieren ingreso hospitalario todos los pacientes con síncope de alto riesgo, síncope recidivante y los de origen cardiológico o neurológico demostrado. Los pacientes con síncope de alto riesgo y recidivantes ingresan en el área de observación del servicio de urgencias, mientras se dilucida su etiología, y los restantes lo hacen en el área de hospitalización correspondiente.

Los pacientes con un síncope único, de características inespecíficas o de origen vasovagal, sin antecedentes relevantes y sin hallazgos patológicos en la exploración física y en las exploraciones complementarias realizadas (electrocardiograma y glucemia), son dados de alta desde el área de consultas del servicio de urgencias.

TRATAMIENTO

El tratamiento específico del síncope depende de su etiología y es objeto de análisis en otros capítulos de esta obra. Sin embargo, a continuación, se exponen de manera resumida las medidas terapéuticas básicas y las recomendaciones para las causas de síncope más frecuentes.

SÍNCOPE VASOVAGAL

- Colocar al paciente en decúbito supino y elevarle los miembros inferiores.
- Evitar bipedestaciones prolongadas y ambientes muy calurosos.
- Aumentar la ingesta de líquidos y sal.

SÍNCOPE ORTOSTÁTICO Y SÍNCOPE POR HIPOTENSIÓN POSPRANDIAL

- Colocar al paciente en decúbito y elevarle los miembros inferiores.
- Suspender la administración de fármacos vasoactivos.
- Tratar la causa de la depleción de volumen, si la hay.
- Prescribir medias elásticas.
- Recomendar al paciente que se incorpore lentamente del decúbito.

SÍNCOPE MICCIONAL

- Evitar la toma de alcohol y la sobrecarga de líquidos.
- Recomendar al paciente que permanezca sentado durante la micción.

SÍNCOPE POR HIPERSENSIBILIDAD DEL SENO CAROTÍDEO

El tratamiento depende del mecanismo implicado en su producción:

- **Mecanismo cardioinhibitorio:**
 - No presionar el cuello. El paciente debe tener precaución al afeitarse, no debe ponerse corbata ni abrocharse el cuello de la camisa, ni realizar movimientos bruscos de la cabeza.

- Si estas medidas preventivas no son suficientes, pueden administrarse anticolinérgicos, como trihexifenidilo (comprimidos de 2 y 5 mg), en dosis de 5 mg/8 h por vía oral.
- En ocasiones es necesaria la implantación de un marcapasos.
- **Mecanismo vasodepresor.** Se administra tartrato de ergotamina (comprimidos con 1 mg de ergotamina, 100 mg de cafeína y 300 mg de paracetamol), en dosis de 1 comprimido/6 h por vía oral.

SÍNCOPE CARDIOGÉNICO

- **Valvulopatía aórtica.** No deben realizarse esfuerzos físicos; hay que valorar la intervención quirúrgica.
- **Arritmias.** El tratamiento es el de la arritmia que lo desencadene (v. caps. 21 a 24).
- **Miocardopatía hipertrófica obstructiva.** Se administran bloqueadores β , como atenolol (comprimidos de 50 y 100 mg), en dosis inicial de 50 mg/24 h por vía oral.

Bibliografía recomendada

- Canakci ME, Sevik OE, Acar N. How should we approach syncope in the Emergency Department? Current perspectives. *Open Access Emerg Med* 2022;14:299-309.
- Hampel KG, Garcés Sánchez M, Gómez Ibañez A, et al. Desafíos diagnósticos en epilepsia. *Revista de Neurología* 2019;68:255-63.
- Krahn AD, Behr ER, Hamilton R, Probst V, Laksman Z, Han HC. Brugada Syndrome. *JACC Clin Electrophysiol* 2022;8:386-405.
- Sandhu RK, Sheldon RS. Syncope in the Emergency Department. *Front Cardiovasc Med* 2019;6:180.
- Sutton R, Ricci F, Fedorowski A. Risk stratification of syncope: Current syncope guidelines and beyond. *Auton Neurosci* 2021;238:102929.
- Wieling W, Kaufmann H, Claydon VE, van Wijnen VK, Harms MPM, Juraschek SP, et al. Diagnosis and treatment of orthostatic hypotension. *Lancet Neurol* 2022;21:735-46.